

50～70%である。しかし SCC 抗原は正常な扁平上皮および肝細胞、胸腺細胞にも存在するために疑陽性率が高い。CYFRA は扁平上皮癌で 70～80%の陽性率であり、肺腺癌でも 10～45%で陽性を認めるが、肺良性疾患の疑陽性率が低く、肺癌特異性が高い。

c 確定診断

肺癌の確定診断には病変部から採取した組織または細胞による病理診断が必要である。肺癌は組織型、ドライバー遺伝子変異、PD-L1 検査によって治療方針が異なるために確定診断は重要となる。

方法としては肺病変に対するラジアル型 EBUS や仮想気管支鏡ナビゲーションを用いた経気管支生検や肺門・縦隔リンパ節に対する超音波気管支鏡ガイド下針生検などが行われる。

d 病期分類

病期分類は UICC-TNM 分類（第 9 版）、『肺癌取扱い規約第 9 版』に準じて行う。

治療と予後

肺扁平上皮癌の治療は、年齢、PS (performance status)、病期、ドライバー遺伝子発現、PD-L1 発現によって決定される。『肺癌診療ガイドライン 2025 年版』⁸⁾において非小細胞肺癌の薬物選択に対して扁平上皮癌と非扁平上皮癌を分けた治療選択が推奨されている。

肺扁平上皮癌は重喫煙者に多く、間質性肺炎を併存している場合も多く存在しているために治療関連肺炎には注意が必要である。

a I～III 期（切除可能）

非扁平上皮癌と同様に外科切除が原則である。臨床病期 I A1～2 期、においては充実成分最大径/腫瘍最大径比 (CTR) で術式の選択が行われる。CTR ≤ 0.25 の肺野末梢非小細胞肺癌では縮小手術（区域切除または楔状切除）、0.25 < CTR ≤ 0.5 では区域切除、0.5 < CTR では区域切除または肺葉切除がそれぞれ推奨されている。I A3～II 期においては肺葉切除が推奨となっている。しかし医学的な理由（呼吸機能低下、併存疾患など）で上記の手術が困難な場合は縮小手術や根治的放射線治療が候補となる。完全切除例に対しては術後補助化学療法が標準治療となっている。術後病理病期 I A3～II A 期および病理病期にて N0 の症例の II B～III A 期の症例では tegafur/uracil 配合剤 (UFT) 療法 2 年間で提案されている。しかし提案の根拠になったメタアナリシスでは扁平上皮癌の検討症例数が少数であり、生存期間のサブグループ解析では腺癌がハザード比 (HR) 0.69 (95%信頼区間: 0.56～0.85) に対して扁平上皮癌では HR 0.82 (95%信頼区間: 0.57～1.19) であることからエビデンスが十分とはいえ安全性に十分考慮して検討される必要がある。術後病理病期 II～III B 期においては cisplatin

(CDDP) 併用療法 [CDDP+VNR] が推奨されている。また EGFR 遺伝子変異陽性症例であれば osimertinib での追加療法が推奨され、ALK 融合遺伝子陽性症例では CDDP 併用療法の代わりに alectinib による治療が提案されている。PD-L1 発現 50%以上例に対しては CDDP 併用療法後に atezolizumab 単剤療法の追加を提案されている。

臨床病期 II～III B 期において術前補助化学療法として扁平上皮癌では CDDP+gemcitabine (GEM)+nivolumab 療法、術前・術後補助化学療法として扁平上皮癌では CDDP+GEM+pembrolizumab の術前化学療法および pembrolizumab 単剤の術後補助化学療法が承認され提案されているが術後補助化学療法との明確な使い分けはなく、患者のリスク/ベネフィットのバランスを考慮して治療選択する必要がある。

b III 期（切除不能）

切除不能と判断された場合、非扁平上皮癌と同様に化学放射線同時併用療法が標準治療となる。放射線は、1 回 1.8～2 Gy で週 5 回、総線量は少なくとも 60 Gy 以上で行い（一般的には 60 Gy が使用される）、74 Gy の高線量照射は行わないように推奨されている。化学療法レジメンは carboplatin (CBDCA)+paclitaxel (PTX)、CDDP+docetaxel (DTX) などが推奨され、71 歳以上の場合は CBDCA 連日投与も推奨されている。地固め療法として免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) として durvalumab が推奨されている。

c IV 期

扁平上皮癌に対する IV 期の全身化学療法についてはドライバー遺伝子変異/転座陽性症例であれば各々のドライバー遺伝子に対する標的療法が推奨される。標的療法の適応となるドライバー遺伝子変異/転移陽性例は腺癌症例に多く認められるが、扁平上皮癌でも認められる場合がある。ドライバー遺伝子変異/転座陰性症例では PD-L1 発現によるサブグループ分類に従って治療が行われる。

i) PD-L1 TPS 50%以上

ECOG Performance status (PS) 0～1 の症例では免疫チェックポイント阻害薬である PD-1/PD-L1 阻害薬単剤での治療もしくはプラチナ併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬を併用した治療を行うように推奨されている。

EGFR 遺伝子変異や ALK 融合遺伝子のない、PD-L1 TPS 50%以上の PS 0～1 の IV 期非小細胞肺癌患者を対象として pembrolizumab 単剤療法とプラチナ併用療法を比較する第 III 相試験において無増悪生存期間 (PFS)、全生存期間 (OS) を pembrolizumab 単剤療法が有意に延長することが示された。

SP142 を用いた PD-L1 免疫染色で TC1 もしくは ICI 以上 (PD-L1 発現ありに相当)、PS 0～1 の IV 期